HER HAFTA BİR VAKA™ · BONUS 1

100 Yorumlu Vaka Sorusu

Kısa klinik veriler, tek soru, dört seçenek. 10 blokta 100 vaka; her bloğun sonunda cevap anahtarı ve neden doğru olduğunu anlatan kısa yorum.

İçindekiler

Nasıl çözülür

Blok 1 · Temel teşhis ve sınıflama · Soru 1–10

Blok 2 · Sefalometri · Soru 11–20

Blok 3 · Planlama ve zamanlama · Soru 21–30

Blok 4 · Yer yönetimi · Soru 31–40

Blok 5 · Ankraj ve mini vidalar · Soru 41–50

Blok 6 · Sınıf II · Soru 51–60

Blok 7 · Sınıf III · Soru 61–70

Blok 8 · Vertikal ve transversal problemler · Soru 71–80

Blok 9 · Yardımcı mekanikler · Soru 81–90

Blok 10 · Bitirme, pekiştirme, travma ve ankiloz · Soru 91–100

Sonraki adım

BAŞLARKEN

Nasıl çözülür

Bir blok yaklaşık 15 dakika. Haftada bir blok, 52 haftalık programla paralel ilerler.

1. **Bloğu süre tutarak çözün.** Cevaplarınızı sorunun yanına yazın; cevap anahtarına bakmayın.
2. **Anahtarla karşılaştırın.** Yanlış veya emin olmadan doğru yaptığınız soruların yorumunu okuyun.
3. **Kaynağa dönün.** Her bloğun başında Başucu Kitabı'ndaki ilgili modül ve Görsel Harita numaraları yazar.
4. **Puanınızı yazın.** Blok sonundaki satıra doğru sayınızı ve tarihi not edin; bir ay sonra aynı bloğu tekrar çözün.

BLOK	KONU	ÖNERİLEN HAFTA
1–2	Temel teşhis, sefalometri	Hafta 1–11 sırasında veya sonrasında
3	Planlama ve zamanlama	Hafta 12–16
4–5	Yer yönetimi, ankraj ve mini vidalar	Hafta 17–23
6–7	Sınıf II, Sınıf III	Hafta 24–31
8	Vertikal ve transversal problemler	Hafta 32–38
9	Yardımcı mekanikler	Hafta 39–43
10	Bitirme, pekiştirme, travma ve ankiloz	Hafta 44–52

Vakalar eğitim amaçlıdır

Veriler kurgusaldır ve tek bir kavramı ölçmek için sadeleştirilmiştir. Gerçek hastada karar tam muayene ve kayıtlarla verilir.

BLOK 1 · SORU 1–10

Temel teşhis ve sınıflama

Okuma: Modül 01 ve Modül 02 · Görsel Harita 1, 2, 9, 10, 17, 37, 38

Soru 1

VAKA

13 yaş. Molar ilişki iki tarafta Sınıf II tam birim. Overjet 8 mm, üst kesiciler prokline.

Angle sınıflaması nedir?

A) Sınıf II bölüm 1
B) Sınıf I
C) Sınıf II bölüm 2
D) Sınıf III

Soru 2

VAKA

15 yaş. Molar ilişki Sınıf II. Üst santraller retrokline, lateraller prokline, overbite derin.

En olası sınıflama hangisidir?

A) Sınıf II bölüm 1
B) Sınıf I derin kapanış
C) Psödo Sınıf III
D) Sınıf II bölüm 2

Soru 3

VAKA

10 yaş. Sağ molar Sınıf I, sol molar Sınıf II yarım birim. Alt orta hat 2 mm sola kaymış.

İlk yapılacak şey nedir?

A) Hemen sol tarafa Sınıf II elastik başlamak
B) Sol üst premolar çekimi planlamak
C) Sentrik ilişkide kapanışı kontrol edip fonksiyonel kaymayı gerçek asimetriden ayırmak
D) Hiçbir işlem yapmadan bir yıl beklemek

Soru 4

VAKA

9 yaş. Sağ tarafta posterior çapraz kapanış. Sentrik ilişkide orta hatlar çakışıyor, sentrik oklüzyonda alt orta hat sağa kayıyor.

En olası tanı nedir?

A) Gerçek mandibular asimetri
B) Üst çene darlığına bağlı fonksiyonel kayma
C) Tek dişlik dental çapraz kapanış
D) TME ankilozu

Soru 5

VAKA

25 yaş. Dinlenmede üst kesici görünürlüğü fazla. Üst dudak boyu ve kron uzunlukları normal. Gülüşte dişeti belirgin.

Hangi neden en çok düşünülür?

A) Vertikal maksiller fazlalık veya üst dentoalveolar ekstrüzyon

B) Kısa üst dudak

C) Pasif sürme

D) Mandibular retrüzyon

Soru 6

VAKA

11 yaş. Sağ üst kanin bukkalde palpe edilemiyor, sol taraf palpe ediliyor. Süt kanin yerinde.

Doğru yaklaşım hangisidir?

A) İki yıl hiçbir kayıt almadan beklemek

B) Hemen cerrahi açma ve traksiyon başlatmak

C) Süt kanini kontrol etmeden bırakmak

D) Panoramik ile pozisyonu değerlendirmek, gerekirse ek (3B) görüntüleme planlamak

Soru 7

VAKA

Alt arkta 7 mm çapraşıklık var. Alt Spee eğrisi yaklaşık 3 mm.

Alt arktaki toplam yer ihtiyacı en iyi nasıl yorumlanır?

A) Tam olarak 7 mm'dir

B) 4 mm'dir, Spee eğrisi yer kazandırır

C) 7 mm'den fazladır; Spee eğrisinin düzeltilmesi de yer ister

D) Spee eğrisi yer analizinde hesaba katılmaz

Soru 8

VAKA

Bolton analizinde anterior oran yüksek: alt anterior dişler üstlere göre büyük.

Hangi çözüm seçenek olarak düşünülür?

A) Bolton uyumsuzluğunun klinik etkisi yoktur

B) Alt anteriorda IPR veya üst lateral kesicilerin restoratif olarak büyütülmesi

C) Üst premolar çekimi şarttır

D) Hızlı üst çene genişletmesi gerekir

Soru 9

VAKA

14 yaş. Ağız açılırken sola deviasyon, sağ TME'de klik. Ağrı yok.

Tedavi öncesinde ne yapılır?

A) Bulguyu başlangıç kaydına yazmak, hastayı ve aileyi bilgilendirmek, gerekirse ileri değerlendirme istemek

B) Ağrı olmadığı için not almamak

C) Tedaviyi kesinlikle reddetmek

D) Hemen fonksiyonel aparey takmak

Soru 10

VAKA

8 yaş. Alt daimi kesicilerde yaklaşık 2 mm çapraşıklık. Süt kanin ve süt molarlar yerinde.

Doğru yorum hangisidir?

A) Mutlaka premolar çekimi gerekir

B) Hızlı üst çene genişletmesi şarttır

C) Hemen sabit tedaviye başlanmalıdır

D) Karma dişlenmede sık görülür; yer analizi ve leeway aralığı ile takip edilir

Blok 1 · Cevaplar ve yorumlar

SORU	CEVAP	YORUM
1	A	**Sınıf II bölüm 1.** Artmış overjet ve prokline üst kesiciler bölüm 1'i gösterir. İskeletsel kaynak sefalometriyle ayrıca değerlendirilir.
2	D	**Sınıf II bölüm 2.** Retrokline santraller, prokline lateraller ve derin kapanış bölüm 2'nin tipik paternidir.
3	C	**Sentrik ilişkide kapanışı kontrol edip fonksiyonel kaymayı gerçek asimetriden ayırmak.** Tek taraflı sınıf farkı ve orta hat kayması önce CR-CO kontrolü ister; mekanik ancak neden belli olduktan sonra seçilir.
4	B	**Üst çene darlığına bağlı fonksiyonel kayma.** Sentrik ilişkide orta hatların düzelmesi fonksiyonel kaymanın temel bulgusudur.
5	A	**Vertikal maksiller fazlalık veya üst dentoalveolar ekstrüzyon.** Dudak boyu ve kron uzunluğu normalse dişeti gülüşü için vertikal maksiller ve dentoalveolar nedenler öne çıkar.
6	D	**Panoramik ile pozisyonu değerlendirmek, gerekirse ek (3B) görüntüleme planlamak.** Tek taraflı palpe edilememe gömülü kanin için uyarı işaretidir; önce pozisyon ve komşu kökler değerlendirilir.
7	C	**7 mm'den fazladır; Spee eğrisinin düzeltilmesi de yer ister.** Derin Spee eğrisini düzleştirmek ark çevresinde ek yer gerektirir.
8	B	**Alt anteriorda IPR veya üst lateral kesicilerin restoratif olarak büyütülmesi.** Diş boyutu uyumsuzluğu bitirmede overjet ve kontakları etkiler; IPR veya restoratif düzenleme ile dengelenebilir.
9	A	**Bulguyu başlangıç kaydına yazmak, hastayı ve aileyi bilgilendirmek, gerekirse ileri değerlendirme istemek.** TME bulguları tedavi başlamadan kayda geçirilmelidir; hasta bilgilendirilir ve gerekirse ileri değerlendirme yapılır.
10	D	**Karma dişlenmede sık görülür; yer analizi ve leeway aralığı ile takip edilir.** Erken karma dişlenmede hafif alt kesici çapraşıklığı sık görülür; takip ve yer analizi ile karar verilir.

Doğru sayısı: ___ / 10 Tarih: Tekrar tarihi:

BLOK 2 · SORU 11–20

Sefalometri

Okuma: Modül 02 · Görsel Harita 3, 40, 41, 42 · Sefalometrik Ölçüm Alıştırma Defteri

Soru 11

VAKA

SNA 82°, SNB 76°, ANB 6°.

En doğru yorum hangisidir?

A) Maksiller prognati ağırlıklı iskeletsel Sınıf II
B) İskeletsel Sınıf I
C) İskeletsel Sınıf III
D) Mandibular retrüzyon ağırlıklı iskeletsel Sınıf II

Soru 12

VAKA

SNA 86°, SNB 80°, ANB 6°.

En doğru yorum hangisidir?

A) Mandibular retrüzyon ağırlıklı iskeletsel Sınıf II
B) İskeletsel Sınıf III
C) Maksiller prognati ağırlıklı iskeletsel Sınıf II
D) Normal sagital ilişki

Soru 13

VAKA

ANB 2°, Wits +5 mm. SN düzlemi belirgin eğimli görünüyor.

Nasıl yorumlanmalı?

A) ANB normal olduğu için hasta kesin iskeletsel Sınıf I'dir
B) ANB yanıltıcı olabilir; Wits, profil ve diğer ölçümlerle birlikte değerlendirilir
C) Wits değerinin klinik önemi yoktur
D) SN eğiminin ANB'ye etkisi olmaz

Soru 14

VAKA

FMA 34°, SN-GoMe 40°.

Vertikal patern nedir?

A) Hiperdiverjan
B) Hipodiverjan
C) Normodiverjan
D) Bu değerlerle değerlendirilemez

Soru 15

VAKA

FMA 18°. Overbite derin.

Bu vertikal paternde hangi ifade doğrudur?

A) Molar ekstrüzyonu kesinlikle kontrendikedir

B) Açık kapanış riski yüksektir

C) Vertikal kontrol için posterior intrüzyon önceliklidir

D) Posterior ekstrüzyon daha iyi tolere edilir, ancak derin kapanış eğilimi fazladır

Soru 16

VAKA

IMPA 102°. Sınıf II kamuflaj için uzun süreli Sınıf II elastik planlanıyor.

En önemli risk hangisidir?

A) Alt kesicilerin retroklinasyonu

B) Üst molarların intrüzyonu

C) Alt kesici proklinasyonunun daha da artması; periodontal ve stabilite riski

D) Overbite'ın kendiliğinden artması

Soru 17

VAKA

U1-SN 115°. Overjet 8 mm, ANB 3°.

Overjet için en doğru yorum hangisidir?

A) Overjet tamamen iskeletseldir

B) Overjetin önemli bir bölümü üst kesici proklinasyonundan kaynaklanıyor

C) Üst kesiciler retroklinedir

D) Kesici eğiminin overjetle ilişkisi yoktur

Soru 18

VAKA

Sınıf III hasta. ANB −3°, IMPA 80°, U1-SN 112°.

Kesici eğimleri neyi gösterir?

A) Doğal dentoalveolar kompansasyon: üst kesiciler prokline, alt kesiciler retrokline

B) Dekompansasyon tamamlanmış

C) Her iki kesici de normal eğimde

D) Üst kesiciler retrokline, alt kesiciler prokline

Soru 19

VAKA

Trazlamada mandibular düzlemi çiziyorsunuz.

SN-GoMe açısı için mandibular düzlem hangi noktalardan geçer?

A) Porion ve Orbitale

B) Sella ve Nasion

C) ANS ve PNS

D) Gonion ve Menton

Soru 20

VAKA

FMA ölçmek için Frankfort yatay düzlemini çiziyorsunuz.

Frankfort düzlemi hangi noktalarla tanımlanır?

A) Sella ve Nasion

B) ANS ve PNS

C) Porion ve Orbitale

D) Gonion ve Menton

Blok 2 · Cevaplar ve yorumlar

SORU	CEVAP	YORUM
11	**D**	**Mandibular retrüzyon ağırlıklı iskeletsel Sınıf II.** SNA normal, SNB düşük: farkı mandibula oluşturuyor.
12	**C**	**Maksiller prognati ağırlıklı iskeletsel Sınıf II.** SNB normal, SNA yüksek: farkı maksilla oluşturuyor.
13	**B**	**ANB yanıltıcı olabilir; Wits, profil ve diğer ölçümlerle birlikte değerlendirilir.** ANB, SN düzleminin eğiminden ve Nasion'un konumundan etkilenir; uyumsuzlukta ek ölçümler belirleyicidir.
14	**A**	**Hiperdiverjan.** Her iki açı da klasik normların (FMA yaklaşık 25°, SN-GoMe yaklaşık 32°) belirgin üzerinde.
15	**D**	**Posterior ekstrüzyon daha iyi tolere edilir, ancak derin kapanış eğilimi fazladır.** Hipodiverjan patern posterior ekstrüzyonu tolere eder; derin kapanış ve nüks eğilimi akılda tutulur.
16	**C**	**Alt kesici proklinasyonunun daha da artması; periodontal ve stabilite riski.** Sınıf II elastikleri alt kesicileri öne eğer; zaten prokline kesicilerde bu sınırlayıcıdır.
17	**B**	**Overjetin önemli bir bölümü üst kesici proklinasyonundan kaynaklanıyor.** U1-SN normalin belirgin üzerinde, ANB normal sınırda: dental bileşen ağır basıyor.
18	**A**	**Doğal dentoalveolar kompansasyon: üst kesiciler prokline, alt kesiciler retrokline.** Sınıf III'te kesiciler iskeletsel uyumsuzluğu gizleyecek şekilde eğilir; cerrahi planda bu kompansasyon kaldırılır.
19	**D**	**Gonion ve Menton.** SN-GoMe, SN düzlemi ile Go-Me düzlemi arasındaki açıdır.
20	**C**	**Porion ve Orbitale.** Frankfort yatay düzlemi Porion ile Orbitale'den geçer.

Doğru sayısı: ___ / 10 Tarih: Tekrar tarihi:

BLOK 3 · SORU 21–30

Planlama ve zamanlama

Okuma: Modül 03 · Görsel Harita 19, 43–52 · Araç 4

Soru 21

VAKA

13 yaş. Sınıf II bölüm 1, derin kapanış, hafif çapraşıklık. Problem listesini yazacaksınız.

Doğru yaklaşım hangisidir?

A) Önce apareyi seçip problemleri ona göre yazmak

B) Yalnızca hastanın şikâyetini yazmak

C) Problemleri sagital, vertikal, transversal ve yer başlıklarında ayrı yazıp sonra önceliklendirmek

D) Yalnızca sefalometrik değerleri listelemek

Soru 22

VAKA

8 yaş. Tek üst kesici anterior çapraz kapanışta. Sentrik ilişkide uç uca gelebiliyor. Alt kesicide dişeti çekilmesi başlamış.

En uygun karar hangisidir?

A) Daimi dişlenme tamamlanana kadar beklemek

B) Erken düzeltmeyi değerlendirmek

C) Ortognatik cerrahi planlamak

D) Yalnızca gece plağı vermek

Soru 23

VAKA

7 yaş. Hafif Sınıf II eğilim, overjet 4 mm, travma öyküsü yok. Çocuk tedaviye henüz hazır değil.

En uygun yaklaşım hangisidir?

A) Takip etmek ve büyüme döneminde yeniden değerlendirmek

B) Hemen sabit tedaviye başlamak

C) Üst premolar çekimi planlamak

D) Cerrahi konsültasyon istemek

Soru 24

VAKA

18 yaş, erkek. Sınıf III. ANB −6°, Wits −10 mm. Profil şikâyeti belirgin.

En uygun ilk adım hangisidir?

A) Hemen Sınıf III elastikleriyle kamuflaja başlamak

B) Yüz maskesi önermek

C) Hiçbir seçenek sunmadan takibe almak

D) Büyümenin tamamlandığını doğrulamak ve ortognatik cerrahi konsültasyonu önermek

Soru 25

VAKA

16 yaş, kız. Sınıf II, ANB 5°, profil kabul edilebilir. Alt arkta çapraşıklık yok, büyüme büyük ölçüde tamamlanmış.

Hangi seçenek düşünülebilir?

A) Dört premolar çekimi zorunludur

B) Yüz maskesi

C) Üst premolar çekimli kamuflaj

D) Hızlı üst çene genişletmesi tek başına

Soru 26

VAKA

14 yaş. Sınıf II yarım birim. Elastik ve hareketli aparey uyumu düşük.

Hangisi uyuma en az bağımlıdır?

A) Hareketli fonksiyonel aparey

B) Sabit fonksiyonel aparey veya mini vida destekli mekanik

C) Sınıf II elastikleri

D) Gece kullanılan hareketli plak

Soru 27

VAKA

40 yaş. Periodontal kemik kaybı ve aktif enflamasyon var.

Ortodontiye ne zaman başlanır?

A) Periodontal tedavi tamamlanıp hastalık stabil olduktan sonra

B) Hemen; ortodonti enflamasyonu azaltır

C) Hiçbir zaman başlanamaz

D) Yalnızca implantlar yerleştirildikten sonra

Soru 28

VAKA

Üst sağ lateral kesici konjenital eksik. Kanin formu ve rengi uygun, dişeti seviyesi farklı.

Boşluk kapatma mı açma mı kararı nasıl verilir?

A) Her zaman implant için yer açılır

B) Her zaman boşluk kapatılır

C) Karar yalnızca protez hekimine aittir

D) Kanin morfolojisi, renk, dişeti seviyesi, oklüzyon ve profil birlikte değerlendirilerek ekip kararıyla

Soru 29

VAKA

Mekanik sırayı planlıyorsunuz.

Doğru sıra hangisidir?

A) Bitirme → seviyeleme → çalışma aşaması → pekiştirme

B) Çalışma aşaması → seviyeleme → pekiştirme → bitirme

C) Seviyeleme-hizalama → çalışma aşaması → bitirme → pekiştirme

D) Pekiştirme → seviyeleme → bitirme → çalışma aşaması

Soru 30

VAKA

Bir erişkin vakada VTO hazırlıyorsunuz.

VTO'nun asıl amacı nedir?

A) Kesin sonucu garanti etmek

B) Planlanan değişikliklerin profile ve oklüzyona olası etkisini önceden görmek

C) Kliniğinizin kullandığı onam formunun yerine geçmek

D) Sefalometriyi gereksiz kılmak

Blok 3 · Cevaplar ve yorumlar

SORU	CEVAP	YORUM
21	**C**	**Problemleri sagital, vertikal, transversal ve yer başlıklarında ayrı yazıp sonra önceliklendirmek.** Problem listesi boyutlara göre yazılır; mekanik en son seçilir.
22	**B**	**Erken düzeltmeyi değerlendirmek.** Fonksiyonel kayma ve periodontal zorlanma erken tedavinin klasik gerekçeleridir.
23	**A**	**Takip etmek ve büyüme döneminde yeniden değerlendirmek.** Erken tedavi gerekçesi yoksa uygun zamanda tek fazlı tedavi çoğu zaman daha verimlidir.
24	**D**	**Büyümenin tamamlandığını doğrulamak ve ortognatik cerrahi konsültasyonu önermek.** Büyük iskeletsel uyumsuzluk ve profil şikâyeti cerrahi seçeneğin konuşulmasını gerektirir.
25	**C**	**Üst premolar çekimli kamuflaj.** Alt ark düzgünse yalnızca üst çekimle kamuflaj, molar Sınıf II bitirme ile planlanabilir.
26	**B**	**Sabit fonksiyonel aparey veya mini vida destekli mekanik.** Uyum düşükse hastanın takıp çıkarmasına bağlı olmayan seçenekler öne çıkar.
27	**A**	**Periodontal tedavi tamamlanıp hastalık stabil olduktan sonra.** Aktif periodontal hastalıkta diş hareketi kemik kaybını hızlandırabilir.
28	**D**	**Kanin morfolojisi, renk, dişeti seviyesi, oklüzyon ve profil birlikte değerlendirilerek ekip kararıyla.** Eksik lateralde tek doğru yoktur; estetik, oklüzal ve periodontal kriterler birlikte tartılır.
29	**C**	**Seviyeleme-hizalama → çalışma aşaması → bitirme → pekiştirme.** Seviyeleme tamamlanmadan rijit çalışma tellerine ve boşluk kapamaya geçilmez.
30	**B**	**Planlanan değişikliklerin profile ve oklüzyona olası etkisini önceden görmek.** VTO bir planlama aracıdır; sonuç garantisi değildir.

Doğru sayısı: ___ / 10 Tarih: Tekrar tarihi:

BLOK 4 · SORU 31–40

Yer yönetimi

Okuma: Modül 04 · Görsel Harita 14, 16, 18, 53–61 · Araç 2

Soru 31

VAKA

17 yaş. Sınıf I. Altta 9 mm çapraşıklık, bimaksiller protrüzyon, dudaklar önde.

En güçlü seçenek hangisidir?

A) Yalnızca IPR
B) Çekimli plan
C) Kesicileri daha da öne alarak çekimsiz plan
D) Yalnızca takip

Soru 32

VAKA

26 yaş. Alt kesicilerde 2,5 mm çapraşıklık. Üçgen kron formu, iyi ağız hijyeni.

Hangi seçenek uygundur?

A) IPR
B) Dört premolar çekimi
C) Hızlı üst çene genişletmesi
D) Ortognatik cerrahi

Soru 33

VAKA

Yüksek çürük riski, yetersiz ağız hijyeni ve küçük kronlar. Alt kesicilerde hafif çapraşıklık.

IPR için doğru karar hangisidir?

A) Mümkün olan en fazla miktarda IPR yapmak
B) IPR'yi cilalamadan bırakmak
C) Risk faktörlerini hesaba katmamak
D) IPR'den kaçınmak veya çok sınırlı tutmak

Soru 34

VAKA

10 yaş. Bilateral posterior çapraz kapanış. Üst çene dar, damak derin.

En uygun seçenek hangisidir?

A) Yalnızca çapraz elastikler
B) Alt arkın daraltılması
C) Hızlı üst çene genişletmesi (RME)
D) Büyüme bitene kadar beklemek

Soru 35

VAKA

22 yaş. İskeletsel transversal darlık. İnce bukkal kemik, ince dişeti fenotipi.

Hangi yaklaşım daha doğrudur?

A) Yalnızca dişleri bukkale eğerek genişletmek

B) Mini vida destekli veya cerrahi destekli genişletmeyi periodontal görüşle değerlendirmek

C) Hiçbir değerlendirme yapmadan RME uygulamak

D) Transversal darlığı görmezden gelmek

Soru 36

VAKA

9 yaş. Sol alt ikinci süt molar erken kaybedilmiş. Alttaki premoların sürmesine daha zaman var. Henüz yer kaybı yok.

En uygun seçenek hangisidir?

A) Yer tutucu

B) Hiçbir şey yapmamak

C) Hemen premolar çekimi

D) Sınıf III elastikleri

Soru 37

VAKA

11 yaş. Alt ikinci süt molarlar hâlâ yerinde. Alt kesicilerde 3 mm çapraşıklık.

Hangi seçenek yer kazanımına katkı sağlayabilir?

A) Süt molarları erken çekmek

B) Alt kesicileri çekmek

C) Hızlı üst çene genişletmesi

D) Leeway aralığını korumak için lingual ark

Soru 38

VAKA

Üst molar distalizasyonu yapılıyor.

Ankraj ünitesinde beklenen yan etki hangisidir?

A) Kesicilerin retroklinasyonu

B) Alt molarların distalizasyonu

C) Premolar ve kesicilerin meziale hareketi ve kesici proklinasyonu

D) Overbite'ın kendiliğinden artması

Soru 39

VAKA

16 yaş. Sınıf II bölüm 1. Alt ark düzgün. Yalnızca üst birinci premolarlar çekilecek.

Bitirmede hedeflenen molar ve kanin ilişkisi nedir?

A) Molar Sınıf I, kanin Sınıf I

B) Molar Sınıf II, kanin Sınıf I

C) Molar Sınıf III, kanin Sınıf II

D) Molar Sınıf I, kanin Sınıf II

Soru 40

VAKA

Alt arkta çekim gerekiyor, ancak alt kesicilerin fazla geri gelmesi istenmiyor.

Hangi çekim tercih edilebilir?

A) Alt ikinci premolar

B) Alt birinci premolar

C) Alt kanin

D) Alt santral kesici

Blok 4 · Cevaplar ve yorumlar

SORU	CEVAP	YORUM
31	**B**	**Çekimli plan.** Şiddetli çapraşıklık ve protrüzyon çekim lehine iki güçlü bulgudur.
32	**A**	**IPR.** Hafif çapraşıklık ve üçgen kron formu IPR için uygun koşullardır.
33	**D**	**IPR'den kaçınmak veya çok sınırlı tutmak.** Çürük riski ve küçük kron boyutu IPR'nin aleyhine olan bulgulardır.
34	**C**	**Hızlı üst çene genişletmesi (RME).** Büyüme döneminde iskeletsel transversal darlık RME ile ele alınabilir.
35	**B**	**Mini vida destekli veya cerrahi destekli genişletmeyi periodontal görüşle değerlendirmek.** Erişkinde ve ince fenotipte yalnız dental genişletme dişeti ve kemik kaybı riskini artırır.
36	**A**	**Yer tutucu.** Erken süt molar kaybında daimi moların meziale hareketi yer kaybına yol açabilir.
37	**D**	**Leeway aralığını korumak için lingual ark.** Süt molarlar değişirken açığa çıkan leeway aralığı korunursa çapraşıklığın çözümüne katkı sağlayabilir.
38	**C**	**Premolar ve kesicilerin meziale hareketi ve kesici proklinasyonu.** Distalizasyon kuvvetine eşit ve zıt kuvvet ankraj dişlerini öne iter.
39	**B**	**Molar Sınıf II, kanin Sınıf I.** Yalnız üst çekimde üst molarlar yerinde kalır; kaninler Sınıf I'e getirilir.
40	**A**	**Alt ikinci premolar.** İkinci premolar çekimi alt kesicilerin daha az geri gelmesine ve molarların meziale hareketine imkân verir.

Doğru sayısı: ___ / 10 Tarih: Tekrar tarihi:

BLOK 5 · SORU 41–50

Ankraj ve mini vidalar

Okuma: Modül 04 · Görsel Harita 11, 62–66

Soru 41

VAKA

Bimaksiller protrüzyon. Dört premolar çekimi, kesicilerin mümkün olduğunca geri alınması isteniyor.

En güvenilir ankraj seçeneği hangisidir?

A) Mini vida ile direkt ankraj

B) Ankraj desteği olmadan elastik zincir

C) Yalnızca Sınıf II elastikleri

D) Yalnızca gece plağı

Soru 42

VAKA

Boşluk kapama sırasında üst molarlar 3 mm meziale geldi, overjet beklenenden az azaldı.

Sorun nedir?

A) Kök rezorpsiyonu

B) Fonksiyonel kayma

C) Bolton uyumsuzluğu

D) Ankraj kaybı

Soru 43

VAKA

TPA kullanmayı düşünüyorsunuz.

TPA'nın temel etkisi hangisidir?

A) Tek başına mutlak sagital ankraj sağlar

B) Alt kesicileri intrüze eder

C) Molarlar arası transversal ilişkiyi korur ve molar rotasyonunu kontrol eder

D) Üst çeneyi iskeletsel olarak genişletir

Soru 44

VAKA

Üst arkta ek ankraj için Nance apareyi planlanıyor.

Nance apareyi desteğini nereden alır?

A) Alt kesicilerden

B) Ön damaktaki mukozaya oturan akrilik butondan

C) Mini vidalardan

D) Ekstraoral bölgeden

Soru 45

VAKA

Mini vida yerleştirmeyi planlıyorsunuz.

Yerleştirme öncesinde öncelikle ne kontrol edilir?

A) Kökler arası mesafe ve kemik miktarı; mümkünse yapışık dişeti

B) Yalnızca hastanın tercih ettiği bölge

C) Yalnızca braket rengi

D) Hiçbir radyografik değerlendirme gerekmez

Soru 46

VAKA

Mini vida yerleştirildikten birkaç hafta sonra mobil.

En olası nedenler hangileridir?

A) Hastanın yaşı her zaman tek nedendir

B) Elastik renginin uygun olmaması

C) Braket tipinin değişmesi

D) Kök teması, yetersiz kemik veya çevresinde enflamasyon

Soru 47

VAKA

Mini vida bir premolara bağlandı, kuvvet premolardan uygulanıyor.

Bu ankraj tipi nedir?

A) Direkt ankraj

B) Ekstraoral ankraj

C) İndirekt ankraj

D) Karşılıklı ankraj

Soru 48

VAKA

Erişkin. Karşı diş kaybı nedeniyle üst birinci molar ekstrüze. Protez için dikey yer gerekiyor.

Hangi mekanik düşünülebilir?

A) Moların daha fazla ekstrüzyonu

B) Mini vida destekli molar intrüzyonu

C) Sınıf II elastikleri

D) Hızlı üst çene genişletmesi

Soru 49

VAKA

Erişkin. Hiperdiverjan patern, anterior açık kapanış 3 mm.

Hangi seçenek vertikal problemi hedef alır?

A) Mini vida ile posterior intrüzyonu değerlendirmek

B) Uzun süreli Sınıf II elastikleri

C) Posterior ekstrüzyon

D) Kontrolsüz dental genişletme

Soru 50

VAKA

Mini vida çevresinde dişeti hiperplazisi ve hassasiyet var.

İlk yaklaşım hangisidir?

A) Kuvveti artırmak

B) Bulguyu görmezden gelmek

C) Mini vidanın yanına ikinci bir vida eklemek

D) Hijyeni ve enflamasyonu kontrol etmek; düzelmezse mini vidayı çıkarıp başka bölgede değerlendirmek

Blok 5 · Cevaplar ve yorumlar

SORU	CEVAP	YORUM
41	**A**	**Mini vida ile direkt ankraj.** Maksimum ankraj gereken vakalarda mini vida en az uyum gerektiren güvenilir seçenektir.
42	**D**	**Ankraj kaybı.** Molarların meziale hareketi ve overjetin yeterince azalmaması ankraj kaybının tipik bulgularıdır.
43	**C**	**Molarlar arası transversal ilişkiyi korur ve molar rotasyonunu kontrol eder.** TPA sagital ankraja sınırlı katkı sağlar; asıl etkisi transversal ve rotasyon kontrolüdür.
44	**B**	**Ön damaktaki mukozaya oturan akrilik butondan.** Nance apareyi akrilik butonla palatal mukozadan destek alır; buton altındaki hijyen kontrol edilir.
45	**A**	**Kökler arası mesafe ve kemik miktarı; mümkünse yapışık dişeti.** Kök teması ve yetersiz kemik başarısızlığın en sık nedenleri arasındadır.
46	**D**	**Kök teması, yetersiz kemik veya çevresinde enflamasyon.** Mobil mini vidada konum, kemik ve hijyen değerlendirilir; gerekirse başka bölgeye yeniden yerleştirilir.
47	**C**	**İndirekt ankraj.** İndirekt ankrajda mini vida bir dişi sabitler, kuvvet o dişten uygulanır.
48	**B**	**Mini vida destekli molar intrüzyonu.** Mini vida, komşu dişleri etkilemeden tek moların intrüzyonuna imkân verir.
49	**A**	**Mini vida ile posterior intrüzyonu değerlendirmek.** Posterior intrüzyon mandibulanın öne-yukarı rotasyonuna izin vererek açık kapanışı azaltabilir.
50	**D**	**Hijyeni ve enflamasyonu kontrol etmek; düzelmezse mini vidayı çıkarıp başka bölgede değerlendirmek.** Enflamasyon başarısızlık riskini artırır; önce hijyen ve yük değerlendirilir.

Doğru sayısı: ___ / 10 Tarih: Tekrar tarihi:

BLOK 6 · SORU 51–60

Sınıf II

Okuma: Modül 05 · Görsel Harita 12, 15, 67–72, 77 · Araç 3

Soru 51

VAKA

12 yaş. Molar Sınıf II. ANB 2°. Üst kesiciler prokline.

Bu Sınıf II ağırlıklı olarak nedir?

A) İskeletsel, mandibular retrüzyon
B) İskeletsel, maksiller prognati
C) Fonksiyonel kayma
D) Dental

Soru 52

VAKA

11 yaş, erkek. SNB 74°, ANB 7°, FMA 24°. Büyüme atılımına yakın, uyumlu.

Hangi seçenek öne çıkar?

A) Ortognatik cerrahi
B) Yüz maskesi
C) Fonksiyonel aparey
D) Yalnızca alt premolar çekimi

Soru 53

VAKA

10 yaş. Overjet 10 mm. Travma öyküsü ve dudak tuzağı var.

En uygun karar hangisidir?

A) Daimi dişlenme tamamlanana kadar beklemek
B) Overjetin erken azaltılmasını değerlendirmek
C) Yalnızca alt kesicileri öne almak
D) Yalnızca takip etmek

Soru 54

VAKA

Twin Block tedavisi sürüyor.

En tipik dentoalveolar yan etki hangisidir?

A) Alt kesici proklinasyonu
B) Alt kesici retroklinasyonu
C) Üst kesici proklinasyonu
D) Posterior çapraz kapanış oluşması

Soru 55

VAKA

Sınıf II elastikleri kullanılıyor.

Hangisi tipik bir yan etkidir?

A) Alt kesici retroklinasyonu

B) Üst molarların intrüzyonu

C) Overjetin artması

D) Alt molar ekstrüzyonu ve alt kesici proklinasyonu

Soru 56

VAKA

FMA 35°. Sınıf II, hafif açık kapanış eğilimi. Uzun süreli Sınıf II elastik düşünülüyor.

Doğru yorum hangisidir?

A) Hiperdiverjan hastada en güvenli seçenektir

B) Vertikal boyuta etkisi yoktur

C) Dikkatli olunmalı; molar ekstrüzyonu mandibulayı posteriora rotate ederek profili kötüleştirebilir

D) Açık kapanışı her zaman kapatır

Soru 57

VAKA

Sınıf II bölüm 2, overbite derin.

Tedavide önce ne yapılır?

A) Hemen Sınıf II elastiklerine başlamak

B) Üst santrallerin eğimini düzeltmek ve derin kapanışı açmak

C) Alt kesicileri çekmek

D) Önce pekiştirme apareyi takmak

Soru 58

VAKA

Büyümesi süren Sınıf II hastada uyum endişesi var.

Hangi seçenek uyum bağımlılığını azaltır?

A) Sabit fonksiyonel aparey

B) Hareketli fonksiyonel aparey

C) Sınıf II elastikleri

D) Gece plağı

Soru 59

VAKA

20 yaş. ANB 9°, overjet 11 mm, belirgin mandibular retrüzyon, profil şikâyeti.

En uygun yaklaşım hangisidir?

A) Yalnızca Sınıf II elastikleri

B) Fonksiyonel aparey

C) Yalnızca IPR

D) Ortognatik cerrahi konsültasyonu

Soru 60

VAKA

Sınıf II kamuflajda üst kesiciler geri alınıyor.

En çok neye dikkat edilir?

A) Kesicilerin olabildiğince dikleşmesine

B) Kuvvetin mümkün olduğunca artırılmasına

C) Tork kontrolüne; kesicilerin aşırı retroklinasyonundan kaçınmaya

D) Overbite'ın derinleşmesine

Blok 6 · Cevaplar ve yorumlar

SORU	CEVAP	YORUM
51	**D**	**Dental.** ANB normalken Sınıf II ilişki dişsel pozisyonla açıklanır.
52	**C**	**Fonksiyonel aparey.** Mandibular retrüzyon, normal vertikal patern ve uygun büyüme dönemi fonksiyonel aparey için uygun koşullardır.
53	**B**	**Overjetin erken azaltılmasını değerlendirmek.** Artmış overjet ve travma öyküsü erken müdahalenin güçlü gerekçeleridir.
54	**A**	**Alt kesici proklinasyonu.** Fonksiyonel apareylerde alt kesiciler öne eğilme eğilimindedir; izlenmelidir.
55	**D**	**Alt molar ekstrüzyonu ve alt kesici proklinasyonu.** Sınıf II elastikleri alt arkı öne çeker ve alt molarları ekstrüze edebilir.
56	**C**	**Dikkatli olunmalı; molar ekstrüzyonu mandibulayı posteriora rotate ederek profili kötüleştirebilir.** Hiperdiverjan patern ekstrüzyon yapan mekaniklere duyarlıdır.
57	**B**	**Üst santrallerin eğimini düzeltmek ve derin kapanışı açmak.** Retrokline kesiciler ve derin kapanış düzeltilmeden sagital ilişki doğru okunamaz.
58	**A**	**Sabit fonksiyonel aparey.** Sabit fonksiyonel apareyler hastanın takıp çıkarmasına bağlı değildir.
59	**D**	**Ortognatik cerrahi konsültasyonu.** Büyümesi tamamlanmış büyük iskeletsel uyumsuzlukta kamuflajın sınırları zorlanır.
60	**C**	**Tork kontrolüne; kesicilerin aşırı retroklinasyonundan kaçınmaya.** Tork kaybı hem estetiği hem overbite'ı olumsuz etkiler.

Doğru sayısı: ___ / 10 Tarih: Tekrar tarihi:

BLOK 7 · SORU 61–70

Sınıf III

Okuma: Modül 05 · Görsel Harita 13, 73–76

Soru 61

VAKA

7 yaş. Anterior çapraz kapanış. Sentrik ilişkide kesiciler uç uca. Dinlenmede profil düz.

En olası tanı nedir?

A) İskeletsel Sınıf III
B) Sınıf II bölüm 2
C) Psödo Sınıf III
D) Makaslama kapanış

Soru 62

VAKA

8 yaş. SNA 77°, SNB 80°, ANB −3°. Negatif overjet.

Hangi seçenek düşünülebilir?

A) Hemen ortognatik cerrahi
B) Erken dönemde yüz maskesi ile maksiller protraksiyon
C) Sınıf II elastikleri
D) Alt premolar çekimi

Soru 63

VAKA

9 yaş. Babada Sınıf III. ANB −2°.

Aileye ne anlatılmalıdır?

A) Erken tedavinin olası faydası, büyümeyle nüks olabileceği ve ileride ek tedavi gerekebileceği
B) Erken tedavinin sorunu kesin ve kalıcı olarak çözeceği
C) Hiçbir tedavinin işe yaramayacağı
D) Yalnızca estetik bir sorun olduğu

Soru 64

VAKA

Erişkin. ANB −2°, profil kabul edilebilir, hasta cerrahi istemiyor.

Kamuflajda kesiciler nasıl hareket ettirilir?

A) Üst kesiciler geri, alt kesiciler öne eğilir
B) Her iki kesici de dikleştirilir
C) Kesiciler hareket ettirilmez
D) Üst kesiciler öne, alt kesiciler geri eğilir

Soru 65

VAKA

Sınıf III ortognatik cerrahi öncesi ortodontik hazırlık.

Hazırlık aşamasının amacı nedir?

A) Kompansasyonu artırmak

B) Negatif overjeti tamamen kapatmak

C) Dekompansasyon: kesicileri kaide kemiğe göre doğru eğime getirmek

D) Cerrahiye gerek kalmayacak kadar düzeltmek

Soru 66

VAKA

Sınıf III elastikleri kullanılıyor.

Tipik yan etki hangisidir?

A) Alt kesici proklinasyonu

B) Üst kesici proklinasyonu, alt kesici retroklinasyonu ve üst molar ekstrüzyonu

C) Üst molar intrüzyonu

D) Overjetin artması

Soru 67

VAKA

Yüz maskesi tedavisi planlanıyor.

En uygun dönem hangisidir?

A) Erken karma dişlenme, maksiller büyüme sürerken

B) Büyüme tamamlandıktan sonra

C) Yalnızca erişkinlikte

D) Daimi ikinci molarlar sürdükten yıllar sonra

Soru 68

VAKA

26 yaş. Tek üst lateral kesici çapraz. Arkta yer yaklaşık 2 mm eksik.

Düzeltme sırası nasıl olmalıdır?

A) Önce kesiciyi zorla labiale itmek

B) Ortognatik cerrahi

C) Hiçbir şey yapmamak

D) Önce yer açmak, sonra kesiciyi labiale hareket ettirmek

Soru 69

VAKA

Anterior çapraz kapanış.

Gerçek iskeletsel Sınıf III'ü düşündüren bulgu hangisidir?

A) Sentrik ilişkide kesicilerin uç uca gelmesi

B) Yalnızca tek kesicinin çapraz olması

C) Sentrik ilişkide de negatif overjetin sürmesi, konkav profil ve aile öyküsü

D) Düz profil ve fonksiyonel kayma

Soru 70

VAKA

15 yaş, erkek. İskeletsel Sınıf III, cerrahi düşünülüyor. Büyüme sürüyor.

Cerrahi zamanlaması nasıl belirlenir?

A) Büyüme sürerken hemen yapılır

B) Büyümenin tamamlanması beklenir; seri kayıtlarla doğrulanır

C) Yaşa bakılmaksızın aynı gün planlanır

D) Zamanlama sonucu etkilemez

Blok 7 · Cevaplar ve yorumlar

SORU	CEVAP	YORUM
61	**C**	**Psödo Sınıf III.** Sentrik ilişkide uç uca temas ve düz profil fonksiyonel ön kaymayı düşündürür.
62	**B**	**Erken dönemde yüz maskesi ile maksiller protraksiyon.** Maksiller retrüzyonda erken protraksiyon büyüme döneminde değerlendirilir.
63	**A**	**Erken tedavinin olası faydası, büyümeyle nüks olabileceği ve ileride ek tedavi gerekebileceği.** Ailesel Sınıf III'te büyüme sonucu değiştirebilir; beklenti baştan doğru kurulur.
64	**D**	**Üst kesiciler öne, alt kesiciler geri eğilir.** Kamuflaj, iskeletsel uyumsuzluğu dentoalveolar kompansasyonla gizler; sınırları gözetilir.
65	**C**	**Dekompansasyon: kesicileri kaide kemiğe göre doğru eğime getirmek.** Dekompansasyon sırasında negatif overjet geçici olarak artabilir; hasta önceden bilgilendirilir.
66	**B**	**Üst kesici proklinasyonu, alt kesici retroklinasyonu ve üst molar ekstrüzyonu.** Sınıf III elastikleri üst arkı öne, alt arkı geriye çeker.
67	**A**	**Erken karma dişlenme, maksiller büyüme sürerken.** Protraksiyonun iskeletsel etkisi erken dönemde daha fazladır.
68	**D**	**Önce yer açmak, sonra kesiciyi labiale hareket ettirmek.** Yer olmadan diş ark içine alınamaz; gerekirse geçici ısırma yükseltmeleri eklenir.
69	**C**	**Sentrik ilişkide de negatif overjetin sürmesi, konkav profil ve aile öyküsü.** Psödo Sınıf III'te sentrik ilişkide uç uca temas mümkündür; gerçek Sınıf III'te değildir.
70	**B**	**Büyümenin tamamlanması beklenir; seri kayıtlarla doğrulanır.** Büyüme sürerken yapılan cerrahi sonrasında mandibular büyüme sonucu bozabilir.

Doğru sayısı: ___ / 10 Tarih: Tekrar tarihi:

BLOK 8 · SORU 71–80

Vertikal ve transversal problemler

Okuma: Modül 06 · Görsel Harita 4–6, 79–92

Soru 71

VAKA

9 yaş. Parmak emme alışkanlığı. Anterior açık kapanış 3 mm. FMA 26°.

En olası tip ve ilk hedef nedir?

A) İskeletsel açık kapanış; ortognatik cerrahi

B) Alışkanlığa bağlı dental açık kapanış; önce alışkanlığın bırakılması

C) Fonksiyonel kayma; RME

D) Derin kapanış; intrüzyon

Soru 72

VAKA

14 yaş. FMA 36°, artmış ön alt yüz yüksekliği, anterior açık kapanış 4 mm.

Bu tablo ne düşündürür?

A) İskeletsel açık kapanış; vertikal kontrol öncelikli

B) Yalnızca dental açık kapanış

C) Hipodiverjan patern

D) Derin kapanış eğilimi

Soru 73

VAKA

11 yaş. Yutkunmada dil kesiciler arasında. Konuşmada "s" sesinde bozulma. Açık kapanış 2 mm.

En uygun yaklaşım hangisidir?

A) Yalnızca dikey elastiklerle kapatmak

B) Hiçbir şey yapmadan beklemek

C) Premolar çekimi

D) Konuşma terapistiyle birlikte multidisipliner plan, gerekirse dil ızgarası

Soru 74

VAKA

Overbite 6 mm. Dinlenmede üst kesici görünürlüğü fazla. Gülüşte dişeti görünüyor.

Derin kapanış nasıl açılmalıdır?

A) Üst kesici ekstrüzyonu

B) Yalnızca posterior ekstrüzyon

C) Öncelikle üst kesici intrüzyonu

D) Sınıf II elastikleri

Soru 75

VAKA

Overbite 6 mm. Dinlenmede üst kesici görünürlüğü az. FMA 20°.

Hangi seçenek daha uygundur?

A) Üst kesici intrüzyonu

B) Posterior ekstrüzyon ve/veya alt kesici intrüzyonu

C) Posterior intrüzyon

D) Hiçbir vertikal mekanik kullanmamak

Soru 76

VAKA

24 yaş. Yalnızca sol üst birinci molar çapraz kapanışta. Üst ark genişliği yeterli.

En uygun yaklaşım hangisidir?

A) Lokal dental düzeltme

B) Hızlı üst çene genişletmesi

C) Cerrahi destekli genişletme

D) Yüz maskesi

Soru 77

VAKA

Tek molar çapraz kapanış için çapraz elastik kullanılıyor.

Tipik yan etki hangisidir?

A) Dişlerde intrüzyon

B) Kesici proklinasyonu

C) Orta hat düzelmesi

D) Dişlerde ekstrüzyon

Soru 78

VAKA

Üst posterior dişler alttakilerin tamamen bukkalinde kapanıyor.

Bu kapanışın adı nedir?

A) Posterior çapraz kapanış

B) Açık kapanış

C) Makaslama kapanış

D) Fonksiyonel kayma

Soru 79

VAKA

18 yaş. Bilateral posterior çapraz kapanış. İnce dişeti fenotipi, premolarlar zaten bukkale eğik.

Hangi seçenek daha güvenlidir?

A) Dişleri daha da bukkale eğmek

B) İskeletsel genişletme seçeneklerini periodontal görüşle değerlendirmek

C) Çapraz elastiklerle uzun süre devam etmek

D) Hiçbir değerlendirme yapmamak

Soru 80

VAKA

Gülüşte dişeti fazla. Klinik kronlar kısa. Kesici görünürlüğü normal.

Hangi neden düşünülmelidir?

A) Pasif sürme; periodontal değerlendirme

B) Vertikal maksiller fazlalık kesin tanıdır

C) Mandibular prognati

D) Fonksiyonel kayma

Blok 8 · Cevaplar ve yorumlar

SORU	CEVAP	YORUM
71	**B**	**Alışkanlığa bağlı dental açık kapanış; önce alışkanlığın bırakılması.** Normal vertikal paternde alışkanlıkla birlikte görülen açık kapanış çoğunlukla dentaldir.
72	**A**	**İskeletsel açık kapanış; vertikal kontrol öncelikli.** Yüksek FMA ve artmış ön alt yüz yüksekliği iskeletsel bileşeni gösterir.
73	**D**	**Konuşma terapistiyle birlikte multidisipliner plan, gerekirse dil ızgarası.** Kas fonksiyonu ele alınmadan kapatılan açık kapanış nükse eğilimlidir.
74	**C**	**Öncelikle üst kesici intrüzyonu.** Fazla kesici görünürlüğü üst kesici intrüzyonunu estetik açıdan tercih edilir kılar.
75	**B**	**Posterior ekstrüzyon ve/veya alt kesici intrüzyonu.** Az kesici görünürlüğünde üst intrüzyon gülüşü olumsuz etkiler; düşük açılı patern posterior ekstrüzyonu tolere eder.
76	**A**	**Lokal dental düzeltme.** Tek dişlik çapraz kapanış ve yeterli ark genişliği dental bir problemi gösterir.
77	**D**	**Dişlerde ekstrüzyon.** Çapraz elastiklerin dikey bileşeni dişleri ekstrüze eder; özellikle hiperdiverjan hastada izlenir.
78	**C**	**Makaslama kapanış.** Makaslama kapanışta temas bukkal-lingual yönde tamamen kaybolmuştur.
79	**B**	**İskeletsel genişletme seçeneklerini periodontal görüşle değerlendirmek.** Kompanse eğilmiş dişlerde ek dental genişletme periodontal riski artırır.
80	**A**	**Pasif sürme; periodontal değerlendirme.** Kısa klinik kronlar ve normal kesici görünürlüğü pasif sürmeyi düşündürür.

Doğru sayısı: ___ / 10 Tarih: Tekrar tarihi:

BLOK 9 · SORU 81–90

Yardımcı mekanikler

Okuma: Modül 07 · Görsel Harita 93–104

Soru 81

VAKA

Boşluk kapama sırasında kesicilerde overbite derinleşiyor ve tork kayboluyor. Tel küçük, kuvvet yüksek.

Ne değiştirilmelidir?

A) Kuvveti azaltmak, slotu daha iyi dolduran rektangüler çelik tele geçmek ve torku kontrol etmek

B) Kuvveti daha da artırmak

C) Daha ince yuvarlak tele geçmek

D) Overbite derinleşmesini görmezden gelmek

Soru 82

VAKA

Kayma mekaniğiyle boşluk kapamaya başlanacak.

Başlamadan önceki şart hangisidir?

A) Esnek NiTi telin yerinde kalması

B) Braketlerin henüz tamamlanmamış olması

C) Pekiştirme apareyinin takılmış olması

D) Seviyelemenin tamamlanmış olması ve uygun rektangüler çalışma teli

Soru 83

VAKA

Halka (loop) mekaniği düşünülüyor.

Temel avantajı hangisidir?

A) Hiç aktivasyon gerektirmemesi

B) Hijyeni kolaylaştırması

C) Sürtünmesiz olması; kuvvet ve moment büküm geometrisiyle ayarlanabilir

D) Hastanın uyumuna bağlı olması

Soru 84

VAKA

Belirgin rotasyonlu bir lateral düzeltildi.

Rotasyon nüksünün temel nedeni nedir?

A) Braket renginin değişmesi

B) Suprakrestal dişeti liflerinin geç yeniden düzenlenmesi

C) Overjetin artması

D) Mini vida kullanılmaması

Soru 85

VAKA

Palatinalde gömülü üst kanin. Yer mevcut, pozisyon belirlenmiş.

Traksiyon öncesinde hangisi önemlidir?

A) Rijit ankraj ünitesi ve kuvvet yönünün komşu köklerden uzak planlanması

B) Kuvvetin mümkün olduğunca yüksek olması

C) Ankraj dişlerin esnek telde bırakılması

D) Ek görüntüleme yapılmaması

Soru 86

VAKA

Gömülü kanin traksiyonunda aylar geçmesine rağmen hareket yok, ankraj dişler intrüze oluyor.

Ne düşünülmelidir?

A) Kuvveti iki katına çıkarmak

B) Ankraj dişlerin intrüzyonunu görmezden gelmek

C) Pekiştirmeye geçmek

D) Ankiloz şüphesi; ayrıntılı değerlendirme (Rehber 4)

Soru 87

VAKA

Alt ikinci molar dikleştiriliyor.

Tipik yan etki hangisidir?

A) Moların intrüzyonu

B) Kesicilerin retroklinasyonu

C) Moların ekstrüzyonu ve erken oklüzal temas

D) Posterior çapraz kapanış

Soru 88

VAKA

Üst arkta hafif-orta dentoalveolar genişletme ve molar derotasyonu gerekiyor.

Hangi aparey uygundur?

A) Yüz maskesi

B) Quad helix

C) Twin Block

D) Sabit lingual pekiştirme

Soru 89

VAKA

Pendulum ile üst molar distalizasyonu yapıldı.

Beklenen yan etki hangisidir?

A) Premolar ve kesicilerin meziale gelmesi; molarlarda distal tipping

B) Kesicilerin retroklinasyonu

C) Molarların meziale tipping'i

D) Alt arkın genişlemesi

Soru 90

VAKA

Üst santralde dişeti altına uzanan kırık. Kök boyu yeterli. Restorasyon sınırı gerekiyor.

Ortodontik katkı ne olabilir?

A) Ortodontik intrüzyon

B) Hızlı üst çene genişletmesi

C) Sınıf III elastikleri

D) Ortodontik ekstrüzyon (zorla sürme)

Blok 9 · Cevaplar ve yorumlar

SORU	CEVAP	YORUM
81	**A**	**Kuvveti azaltmak, slotu daha iyi dolduran rektangüler çelik tele geçmek ve torku kontrol etmek.** Rijit olmayan tel ve fazla kuvvet kesicilerin kontrolsüz geri eğilmesine yol açar.
82	**D**	**Seviyelemenin tamamlanmış olması ve uygun rektangüler çalışma teli.** Seviyeleme bitmeden yapılan boşluk kapama tork ve rotasyon kontrolünü kaybettirir.
83	**C**	**Sürtünmesiz olması; kuvvet ve moment büküm geometrisiyle ayarlanabilir.** Halkalar sürtünme sorununu ortadan kaldırır ama hassas büküm ve aktivasyon ister.
84	**B**	**Suprakrestal dişeti liflerinin geç yeniden düzenlenmesi.** Suprakrestal lifler uzun süre gergin kalır; pekiştirme ve gerekirse fiberotomi değerlendirilir.
85	**A**	**Rijit ankraj ünitesi ve kuvvet yönünün komşu köklerden uzak planlanması.** Kuvvet yönü yanlışsa komşu köklerde rezorpsiyon riski artar.
86	**D**	**Ankiloz şüphesi; ayrıntılı değerlendirme (Rehber 4).** Hareketsizlik ve ankraj dişlerde yan etki ankilozu düşündürür.
87	**C**	**Moların ekstrüzyonu ve erken oklüzal temas.** Dikleştirmede mezial kök ucu çevresinde rotasyon moları yükseltir.
88	**B**	**Quad helix.** Quad helix hafif-orta dental genişletme ve molar derotasyonu için kullanılır.
89	**A**	**Premolar ve kesicilerin meziale gelmesi; molarlarda distal tipping.** Ankraj ünitesi öne gelir; molarlar kontrolsüz distale eğilebilir.
90	**D**	**Ortodontik ekstrüzyon (zorla sürme).** Ekstrüzyon kırık sınırını dişeti üstüne getirerek restorasyonu kolaylaştırır.

Doğru sayısı: ___ / 10 Tarih: Tekrar tarihi:

BLOK 10 · SORU 91–100

Bitirme, pekiştirme, travma ve ankiloz

Okuma: Modül 08 · Görsel Harita 20, 105–114 · Rehber 2 · Rehber 4

Soru 91

VAKA

Bitirmede komşu dişlerin marjinal sırt seviyeleri farklı.

Ne yapılır?

A) Braketleri hemen sökmek

B) Kuvveti artırmak

C) Farkı pekiştirmeyle düzeltmeye çalışmak

D) İlgili braketlerin yeniden konumlandırılması

Soru 92

VAKA

Bitirme aşamasında kök paralelliğini kontrol ediyorsunuz.

Doğru yaklaşım hangisidir?

A) Yalnızca kron görünümüne bakmak

B) Hiçbir radyografi kullanmamak

C) Panoramikte değerlendirmek, distorsiyonu akılda tutup klinik bulgularla birlikte yorumlamak

D) Panoramik görüntüyü kesin ölçüm olarak kabul etmek

Soru 93

VAKA

Bitirme. Alt orta hat 2 mm sağa kaymış. İskeletsel asimetri ve fonksiyonel kayma yok.

Hangi mekanik uygundur?

A) Ortognatik cerrahi

B) Asimetrik mekanik veya asimetrik elastiklerle dental düzeltme

C) Hızlı üst çene genişletmesi

D) Hiçbir düzeltme yapmamak

Soru 94

VAKA

Kesici ilişkileri iyi, ancak premolar bölgede posterior temaslar zayıf.

Hangi yöntem kullanılabilir?

A) Esnek bitirme teli veya kısa süreli dikey elastiklerle oklüzal oturma

B) Braketleri sökmeden kuvveti artırmak

C) Hızlı üst çene genişletmesi

D) Posterior intrüzyon

Soru 95

VAKA

Başlangıçta üst diastema ve alt kesicilerde rotasyonlar vardı.

Hangi pekiştirme önerilir?

A) Pekiştirme gerekmez

B) Yalnızca bir ay hareketli plak

C) Yalnızca ağız bakım önerisi

D) Sabit lingual pekiştirme, gerekirse gece plağıyla birlikte

Soru 96

VAKA

Hijyeni zayıf, sabit lingual istemiyor, uyumlu bir hasta.

Hangi seçenek düşünülebilir?

A) Hiçbir pekiştirme kullanmamak

B) Ortognatik cerrahi

C) Hareketli pekiştirme (Hawley veya şeffaf plak) ve yakın takip

D) Sabit lingual pekiştirmeyi hastanın isteğine rağmen uygulamak

Soru 97

VAKA

Tedavi bitişinden üç yıl sonra alt kesici çapraşıklığı geri gelmiş. Plaklar bırakılmış.

En olası açıklama hangisidir?

A) Tedavinin hiç işe yaramamış olması

B) Pekiştirme uyumsuzluğu ve yaşla devam eden fizyolojik değişimler

C) Yalnızca Bolton uyumsuzluğu

D) Yalnızca TME problemi

Soru 98

VAKA

Kontrolde sabit lingual pekiştirmenin bir bağlantısının koptuğu fark ediliyor. Hasta fark etmemiş.

Ne yapılır?

A) Erken onarım ve o bölgede diş hareketi olup olmadığının kontrolü

B) Bir sonraki yıllık kontrole kadar beklemek

C) Pekiştirmeyi tamamen çıkarıp yeni bir şey önermemek

D) Bulguyu kayda geçirmemek

Soru 99

VAKA

10 yaş. Öyküde üst santrale travma. Ortodontik tedavi planlanıyor.

Başlangıçta ne yapılır?

A) Travma öyküsünü kayda geçirmemek

B) Travmalı dişe en yüksek kuvveti uygulamak

C) Değerlendirme yapmadan tedaviye başlamak

D) Travmalı dişin klinik ve radyografik değerlendirmesi ve kayıt; hafif kuvvet planı

Soru 100

VAKA

Süt molar infraoklüzyonda, komşu dişler üzerine eğilmiş. Altta daimi diş yok.

En olası tanı ve yaklaşım hangisidir?

A) Normal sürme; yalnızca beklemek

B) Fonksiyonel kayma

C) Ankiloz; yer ve kemik seviyesi açısından zamanında ekip kararı

D) Sınıf II elastikleri

Blok 10 · Cevaplar ve yorumlar

SORU	CEVAP	YORUM
91	**D**	**İlgili braketlerin yeniden konumlandırılması.** Marjinal sırt farkı braket konumunun düzeltilmesini gerektirir.
92	**C**	**Panoramikte değerlendirmek, distorsiyonu akılda tutup klinik bulgularla birlikte yorumlamak.** Panoramik görüntü yönlendirici olsa da distorsiyon içerebilir.
93	**B**	**Asimetrik mekanik veya asimetrik elastiklerle dental düzeltme.** Nedeni dental olan orta hat sapması dental mekanikle düzeltilebilir.
94	**A**	**Esnek bitirme teli veya kısa süreli dikey elastiklerle oklüzal oturma.** Settling posterior temasları iyileştirir.
95	**D**	**Sabit lingual pekiştirme, gerekirse gece plağıyla birlikte.** Diastema ve rotasyonlar nüks riski yüksek bulgulardır.
96	**C**	**Hareketli pekiştirme (Hawley veya şeffaf plak) ve yakın takip.** Pekiştirme seçimi hijyen, uyum ve hasta tercihiyle birlikte yapılır.
97	**B**	**Pekiştirme uyumsuzluğu ve yaşla devam eden fizyolojik değişimler.** Dişler ömür boyu hareket eğilimindedir; pekiştirme bu yüzden uzun dönem planlanır.
98	**A**	**Erken onarım ve o bölgede diş hareketi olup olmadığının kontrolü.** Kopan bağlantı fark edilmezse istenmeyen diş hareketi oluşabilir.
99	**D**	**Travmalı dişin klinik ve radyografik değerlendirmesi ve kayıt; hafif kuvvet planı.** Travmalı dişler tedavi öncesinde değerlendirilir ve kayda geçirilir; ayrıntılar Rehber 4'te.
100	**C**	**Ankiloz; yer ve kemik seviyesi açısından zamanında ekip kararı.** Ankilozlu süt molarda gecikme komşu dişlerin eğilmesine ve kemik seviyesi farkına yol açabilir.

Doğru sayısı: ___ / 10 Tarih: Tekrar tarihi:

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

Sonraki adım

100 soruyu bitirdiniz mi? En az doğru yaptığınız iki bloğu seçin ve 52 Haftalık Vaka Çalışma Programı'ndaki ilgili haftalara dönün.

Sefalometri bloğunda 8'in altında kaldıysanız **Sefalometrik Ölçüm Alıştırma Defteri**'ni açın. Kendi vakalarınızı meslektaşlarınızla tartışmak için **Meslektaşlara Vaka Sunumu Şablonları**'nı kullanın.

Kararları koltuk başında hızlandırmak için Başucu Kitabı'nın **Araç 2 · Karar Haritası: Çekim mi, Koruma mı?** ve **Araç 3 · Sınıf II – Sınıf III Görsel Ayırıcı**'sını yanınızda tutun.